

БЕКТЕМ
Кыргыз Республикасынын
Саламаттык сактоо министрлигинин
алдындагы дары каражаттары
жана медициналык буюмдар
департаментинин
директорунун орун басары
Кысанов Т.А.
«31» _____ 2025-ж.



ДАРЫ КАРАЖАТЫН МЕДИЦИНАДА КОЛДОНУУ БОЮНЧА НУСКАМА

АВТОРЕКС

Соодадагы аталышы
Авторекс

Эл аралык патенттелбеген аталышы
Амлодипин

Дарынын түрү
Таблеткалар

Курамы

Авторекс 5мг: ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт

Активдүү зат:

Амлодипин бесилат

5 мг амлодипинге барабар

Көмөкчү заттар: коповидон, маннитол, микрокристаллдуу целлюлоза, тазартылган тальк, натрий крахмалгликолят, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, магний стеараты.

Авторекс 10 мг: ар бир таблетка төмөнкүлөрдү камтыйт

Активдүү зат:

Амлодипин бесилат

10 мг амлодипинге барабар

Көмөкчү заттар: коповидон, маннитол, микрокристаллдуу целлюлоза, тазартылган тальк, натрий крахмалгликолят, суусуз коллоиддүү кремний диоксиди, магний стеараты.

Сүрөттөмөсү

Авторекс 5 мг:

Ак түстөгү, бир өңчөй, тегерек, эки жагы томпок, бир тарабында сызыгы бар таблеткалар.

Авторекс 10 мг:

Ак түстөгү, бир өңчөй, тегерек, бети жалпак, бир тарабында кертиги жана бөлүүчү сызыгы бар таблеткалар.

Фармадарылык тобу

Жүрөк кан тамыр системасы. Кальций каналдарынын блокаторлору. Кан тамырларга артыкчылыктуу таасири менен кальций каналдарынын селективдүү блокаторлору. Дигидропиридинден алынган. Амлодипин

АТХ коду: C08CA01

Фармакологиялык таасири

Фармакодинамикасы

II муундагы жай кальций каналдарын бөгөөчү, дигидропиридинден алынган. Гипертензияга каршы жана антиангиналдык таасир көрсөтөт.

Дигидропиридин рецепторлору менен байланышуу аркылуу кальций каналдарын бөгөйт, кальций иондорунун клеткага (кардиомиоциттерге караганда көбүрөк тамырлардын жылма булчуңдарынын клеткаларына) мембраналар аралык өтүүсүн азайтат. Антиангиналдык таасири коронардык жана четки артериялар менен артериолдорду кеңейтүүсү менен шартталган. Стенокардияда миокарддын ишемиясынын айкындуулугун азайтат.

Четки артериолдорду кеңейтүү менен ЖЧТК азайтат, жүрөккө куюлуучу кандын өлчөмүн азайтат, миокарддын кычкылтекке болгон муктаждыгын азайтат. Миокарддын өзгөрүлбөгөн жана кан менен жабдылуусу азайган зоналарында негизги күрөө тамырларды жана артериолдорду кеңейтүү менен миокардга кычкылтектин келүүсүн көбөйтөт (өзгөчө вазоспастикалык стенокардияда). Коронардык артериялардын тарышынын өрчүүсүн алдын алат (анын ичинде тамеки чегүүдөн пайда болгон).

Стенокардия менен ооругандарда Авторекстин бир жолку суткалык дозасы денеге күч келтирүүнү аткаруу убагын көбөйтөт, стенокардиянын жана ST сегментинин ишемиялык депрессиясынын өрчүүсүн жайлатат, стенокардиянын курч кармоолорунун жана нитраттарды колдонуунун жыштыгын азайтат.

Узакка созулган дозага көз каранды гипотензиялык таасир көрсөтөт. Гипотензиялык таасири тамырлардын жылма булчуңдарына түз бошондотуучу таасирине шартталган. Артериялык гипертензияда бир жолку доза 24 саат бою (оорулуунун жаткан же турган абалында) АБнын клиникалык маанилүү төмөндөшүн камсыз кылат. АБнын чукул төмөндөп кетүүсүн, денеге күч келтирүүдө чыдамдуулуктун, сол карынчанын чыгынды фракциясынын төмөндөшүн пайда кылбайт. Сол карынчанын миокардынын чоңоюшунун деңгээлин азайтат, ЖИДде атеросклерозго каршы жана кардиопротектордук таасир берет. Миокарддын жыйрымдуулугуна жана өткөрүмдүүлүгүнө таасирин тийгизбейт, ЖКТнын рефлексордук көбөйүүсүн пайда кылбайт.

Тромбоциттердин биригүүсүн токтотот, түйдөкчөлүү чыпкалоонун ылдамдыгын жогорулатат, начар натрийуретикалык таасирге ээ.

Диабет нефропатиясында микроальбуминуриянын айкындуулугун көбөйтпөйт.

Заттардын алмашуусуна жана кандын плазмасындагы липиддердин өлчөмүнө жагымсыз таасирин көрсөтпөйт.

Дарылык таасири 2-4 сааттан кийин өрчүйт, таасир берүү узактыгы – 24 саат.

Фармакокинетикасы

Сиңируу: Ичип кабыл алгандан кийин амлодипин АИЖда акырындык менен сиңет. Кабыл алуу убактысы жана тамактын курамы препараттын сиңүү деңгээлине таасирин тийгизбейт. Абсолюттук биожеткиликтүүлүгү 64 % ды түзөт. Стах 6-9 сааттан кийин жетет. Канда амлодипиндин өлчөмүнүн Авторекс препаратынын дозасынан сызыктуу көз карандылыгы айкындалат. Тамакты кабыл алуу амлодипиндин биожеткиликтүүлүгүн өзгөртпөйт.

Бөлүштүрүү: Орточо V_d дененин салмагына 21 л/кг түзөт, бул препараттын көпчүлүк бөлүгү ткандарда, ал эми азыраагы – канда экендигин көрсөтөт. Сss препаратты 7 күн дайыма кабыл алгандан кийин жетет. Кан плазмасындагы белоктор менен байланышы – 95 %. ГЭТ аркылуу кирет.

Зат алмашуу: Амлодипин активдүү эмес метаболиттерди түзүү аркылуу боордо акырындык менен, бирок активдүү зат алмашууга (90 %) кабылат, боор аркылуу «алгачкы жолу өтүү» таасирине кабылат. Метаболиттер маанилүү фармакологиялык активдүүлүккө ээ эмес.

Бөлүн чыгаруу: Бир жолку ичип кабыл алуудан кийин $T_{1/2}$ 31 сааттан 48 саатка чейин ар түрдүү өзгөрүлүп турат, ал эми кайра дайындоодо болжол менен 45 саатты түзөт. Активдүү эмес метаболиттерди түзүү менен амлодипиндин болжол менен 90 % боордо биотрансформацияланат. Бөйрөк аркылуу бөлүнүп чыгарылат: 60 % метаболиттер түрүндө, 10 % - өзгөрүлбөгөн түрдө; заң менен – 20-25 % метаболиттер түрүндө. Эне сүтү менен бөлүнүп чыгат. Жалпы клиренси 0.116 мл/с/кг (7 мл/мүн/кг, 0.42 л/с/кг) түзөт.

Өзгөчө клиникалык учурлардагы фармакокинетикасы: 65 жаштан жогорку улгайган бейтаптарда амлодипинди бөлүн чыгаруу жаш бейтаптарга салыштырмалуу жайыраак ($T_{1/2}$ – 65 саат), бирок бул айырмачылык клиникалык мааниге ээ эмес. Боор алсыздыгы бар бейтаптарда $T_{1/2}$ узаруусу болжолдонот жана узак убакытка дайындоодо организмде препараттын топтолушу жогору болот ($T_{1/2}$ 60 саатка чейин көбөйөт).

Бөйрөк алсыздыгы амлодипиндин кинетикасына олуттуу таасирин тийгизбейт.

Гемодиализде чыгарылбайт.

Колдонууга көрсөтмөлөр

- Артериялык гипертензия (монодарылоо же башка гипотензиялык каражаттар менен айкалыштырып дарылоо).
- Күч келтирүүдөн стенокардия, вазоспастикалык стенокардия (Принцметал стенокардиясы) (монодарылоо же башка антиангиналдык каражаттар менен айкалыштырып дарылоо).

Каршы көрсөтмөлөр

- оор артериялык гипотензия (систоликалык АБ 90 мм сым.мам. кем);
- коллапс;
- кардиогендик шок;
- туруксуз стенокардия (Принцметал стенокардиясын кошпогондо);
- кош бойлуулук;
- бала эмизүү мезгили (бала эмизүү);
- 18 жашка чейинки балдар жана өспүрүмдөр курагы (натыйжалуулугу жана коопсуздугу аныкталган эмес);
- препараттын курам бөлүктөрүнө жогорку сезгичтик;
- дигидропиридиндерге жогорку сезгичтик.

Препаратты боор функциясы бузулганда, СТНБ (айкын брадикардия, тахикардия), декомпенсациялоо баскычындагы өнөкөт жүрөк жетишсиздигинде, жеңил же орто артериялык гипотензияда, аорталык тарышында, митралдык тарууда, гипертрофиялык кептелме жүрөк жетишсиздигинде, курч миокард инфарктында (жана андан кийинки 1 ай ичинде), кант диабетинде, липиддик алмашуунун бузулушунда, улгайган курактагы бейтаптарга этияттык менен дайындоо керек.

Боор функциясы бузулганда колдонуу: боор функциясы бузулганда препаратты этияттык менен дайындоо керек.

Бөйрөк функциясы бузулганда колдонуу: Бөйрөк алсыздыгында дозаны тууралоо талап кылынбайт.

Колдонуу жолу жана дозасы

Суткасына бир жолу, тамакты кабыл алуудан көз карандысыз, жетиштүү көлөмдөгү суу (100 мл) менен ичилет.

Артериялык гипертензияда жана стенокардияда баштапкы доза суткасына 1 жолу 5 мг түзөт. Доза эң жогору суткасына 1 жолу 10 мг чейин көбөйтүлүшү мүмкүн. Дозаны жогорулатууну дарылоо башталгандан 7-14 күн өткөндөн кийин жүргүзүү сунушталат (дозаны тез жогорулатуу бейтапты кылдаттык менен көзөмөлдөөнү талап кылат).

Улгайган курактагы бейтаптарда амлодипиндин $T_{1/2}$ көбөйүшү жана креатинин клиренси (КК) төмөндөшү мүмкүн. Дозаны өзгөртүү талап кылынбайт, бирок бейтаптарга кылдаттык менен көзөмөл жүргүзүү керек.

Тиазиддик диуретиктер, бета-адреноблокаторлор жана ангиотензинге айлануучу ферменттин (ААФ) басаңдаткычтары менен бир убакта колдонууда дозаны өзгөртүү талап кылынбайт.

Бөйрөк алсыздыгы бар бейтаптарда дозаны өзгөртүү талап кылынбайт.

Кыйыр таасири

Жүрөк-кан тамыр системасы тарабынан: жүрөктүн согушу, энтигүү, АБ аяктын төмөндөшү, эстен тануу, васкулит, шишимиктер (кызыл ашыктын томугунун жана буттун кетменинин шишимик тартуусу), бетке кандын шыкалуусу; сейрек – ыргактын бузулушу (брадикардия, карынча тахикардиясы, дүлөйлөрдүн диртилдөөсү), көкүрөк клеткасынын оорушу, ортостатикалык гипотензия; абдан сейрек – миокард инфаркты, көкүрөктүн оорушу.

БНС тарабынан: баш оору, баш айлануу, чаалыгуу, уйкусууроо, маанайдын өзгөрүшү, карышуулар; сейрек – акыл-эсин жоготуу, гипестезия, нервоздуулук, сезимдин бузулуусу, титирөө, вертиго, астения, талмоорсуу, уйкусуздук, чүнчүү, адаттан тыш түш көрүүлөр; тез-тез эмес – четки нейропатия, маанайдын өзгөргүчтүгү, жогорку дүүлүккүчтүк; абдан сейрек – атаксия, апатия, ажитация, амнезия; белгисиз – экстрапирамиддик бузулуулар.

Тамак сиңирүү системасы тарабынан: окшуу, кусуу, курсактын үстүнүн оорушу; сейрек – боор трансаминазаларынын деңгээлинин жогорулашы жана сарык (холестаз менен шартталган), панкреатит, ооздун кургашы, ичтин көбүшү, бүйлө гиперплазиясы, ич катуу же ич өтүү; абдан сейрек – гастрит, табиттин жогорулашы.

Заара-жыныс системасы тарабынан: сейрек – поллакиурия, заара ушатууда оорутуу, никтурия, жыныстык функциянын бузулушу (анын ичинде дармандын төмөндөшү); абдан сейрек – дизурия, полиурия.

Дерматологиялык реакциялар: абдан сейрек – ксеродермия, жаргак баш, дерматит, пурпура, теринин өңүнүн өзгөрүшү.

Дем алуу системасы тарабынан: тез-тез эмес – энтигүү; сейрек – диспноэ; абдан сейрек – жөтөл, ринит.

Сөөк-булчуң системасы тарабынан: сейрек – артралгия, артроз, арканын оорушу, миалгия (узак убакыт колдонууда); абдан сейрек – миастения.

Сезүү органдары тарабынан: сейрек – кош көрүнүү, конъюнктивит, көздүн оорушу, көрүүнүн бузулушу, конъюнктивит, кулактын чуулдашы; абдан сейрек – паросмия, даам сезүүнүн бузулушу, аккомодациянын бузулушу, ксерофтальмия.

Кан жсаратуу органдары тарабынан: сейрек – тромбоцитопения, лейкопения; абдан сейрек – тромбоцитопениялык пурпура.

Аллергиялык реакциялар: теринин кычышуусу, бөртмө (анын ичинде эритематоздук, макуло-папулездик бөртмө, бөрү жатыш), ангионевротикалык шишимик; абдан сейрек – көп түрдүү эритема.

Башка: сейрек – гинекомастия, дененин салмагынын көбөйүшү/азайышы, гипергликемия, мурундан кан агуу; өтө тердөө, суусоо; абдан сейрек – муздак жабышкак тер.

Ашыкча доза

Симптомдору: артериялык басымдын айкын төмөндөшү, тахикардия, чектен тыш четки вазодилатация.

Дарылоо: ашказанды жууп-тазалоо, активдешкен көмүрдү дайындоо, жүрөк- кан тамыр системасынын функциясын колдоо, жүрөк жана өпкө функциясынын көрсөткүчтөрүн көзөмөлдөө, буттарды өйдө көтөрүп коюу, айланган кандын көлөмүн жана зааранын бөлүнүшүн көзөмөлдөө. Тамырлардын чыйралуусун калыбына келтирүү үчүн – тамыр тарытуучу дарыларды колдонуу (аларды колдонууга каршы көрсөтмө жок болсо); кальций каналдарын бөгөөтүнүн кесепеттерин жоюу үчүн – кальций глюконатын кан тамырга куюу. Гемодиализ натыйжасыз.

Башка дары каражаттары менен өз ара таасири

Микросомалык кычкылдануунун басаңдаткычтары кыйыр таасирлердин өрчүү кооптуулугун күчөтүү менен кандын плазмасында амлодипиндин концентрациясын жогорулатат, ал эми боордун микросомалык ферменттеринин индукторлору азайтат.

Гипотензиялык таасирди стероиддик эмес сезгенүүгө каршы препараттар начарлатат, айрыкча индометацин (натрийди кечиктирүү жана бөйрөктөрдүн простагландиндердин синтезин бөгөөсү), альфа-адреностимуляторлор, эстрогендер (натрийдин кармалуусу), симпатомиметиктер. Тиазиддик жана «илмек» диуретиктер, бета-адреноблокаторлор, верапамил, ААФ басаңдаткычтары жана нитраттар ангинага каршы жана гипотензиялык таасирди күчөтөт.

Эритромицин бирге колдонууда амлодипиндин С_{max} жаш бейтаптарда - 22 % га, ал эми улгайган бейтаптарда - 50 % га жогорулатат.

Артериялык гипертензиясы бар бейтаптарда 100 мг силденафилди бир жолу кабыл алуу амлодипиндин фармакокинетикасынын параметрлерине таасир бербейт.

10 мг дозасында амлодипин менен 80 мг дозасында аторвастатинди кайрадан колдонуу аторвастатиндин фармакокинетикасынын көрсөткүчтөрүнүн маанилүү өзгөрүүлөрү менен коштолбойт.

Этанол (алкоголду камтыган ичимдиктер): амлодипин 10 мг дозасында бир жолку жана кайра колдонууда этанолдун фармакокинетикасына таасир бербейт.

Вируска каршы каражаттар (ритонавир) ЖККТ, анын ичинде амлодипиндин да плазмалык концентрациясын көбөйтөт.

Амиодарон, хинидин, альфа 1-адреноблокаторлор, антипсихотикалык дары каражаттары (нейролептиктер) жана «жай» кальций каналдарынын тоскучтары гипотензиялык таасирди күчөтөт.

Дигоксиндин жана варфариндин фармакокинетикалык параметрлерине таасирин тийгизбейт.

Циметидин амлодипиндин фармакокинетикасына таасир бербейт.

Литий препараттары менен бирге колдонууда алардын нейротоксиндүүлүк көрүнүштөрү (окшуу, кусуу, ич өтүү, атаксия, титирөө, кулактын чуулдашы) күчөшү мүмкүн.

Кальций препараттары «жай» кальций каналдарынын блокаторлорунун таасирин азайтышы мүмкүн.

Прокаинамид, хинидин жана QT аралыгынын узарышын пайда кылуучу башка дары каражаттары терс инотроптук таасирди күчөтөт жана QT аралыгынын бир кыйла узаруу кооптуулугун жогорулатат.

Грейпфрут ширеси кандын плазмасында амлодипиндин концентрациясын төмөндөтөт, бирок бул төмөндөө өтө эле аз болгондуктан, амлодипиндин таасирин кыйла өзгөртө албайт.

Өзгөчө көрсөтмөлөр

Дарылоо мезгилинде дененин салмагын жана натрийди колдонууну көзөмөлдөө керек.

Ооз көңдөйүнүн тазалыгын сактоо жана тиш дарыгерине бат-бат баруу керек (бүйлөөнүн оорутуусун, каноосун жана гиперплазиясын алдын алуу үчүн).

НУНА классификациясы боюнча III жана IV функциялык класстагы өнөкөт жүрөк жетишсиздиги бар бейтаптарда Авторекс препаратын колдонууда өпкө шишимигинин өрчүшү мүмкүн.

Улгайгандар үчүн дозалоо режими башка курактык топтордогу бейтаптардыкындай эле.

Дозаны көбөйтүүдө улгайган бейтаптарга кылдаттык менен көзөмөл жүргүзүү керек.

«Жай» кальций каналдарынын блокаторлорунда «токтотуу» синдрому жок болгондугуна карабастан, дарылоону токтотуу алдында дозаны акырындык менен азайтуу сунушталат.

Авторекс калийдин өлчөмүнө жана глюкозанын, триглицериддердин, жалпы холестериндин, төмөнкү тыгыздыктагы липопротеиндердин (ТТЛП), заара кислотасынын, креатининдин жана заара кислотасынын азотунун плазмалык концентрациясына таасирин тийгизбейт. Авторекс тиазид диуретиктери, альфа-адреноблокаторлор, бета-адреноблокаторлор же ААФ басаңдаткычтары менен айкалыштырылып артериялык гипертензияны дарылоо үчүн колдонулушу мүмкүн. Туруктуу жүрөк мыкчылуусу бар бейтаптарда препаратты башка ангинага каршы каражаттар, мисалы узак же кыска таасир берүүчү нитраттар же бета-адреноблокаторлор менен айкалыштырууга болот.

Кош бойлуулукта жана бала эмизүү мезгилинде колдонуу

Препарат кош бойлуулукта жана бала эмизүү мезгилинде (эне сүтүн эмизүү) каршы көрсөтүлгөн.

Унаа каражаттарын жана механизмдерди башкаруу жондөмдүүлүгүнө таасири

Авторекстин унаа каражаттарын башкарууга же механизмдер менен иштөөгө тийгизген таасири жөнүндө билдирүүлөр болгон эмес. Ошондой болсо да, айрым бейтаптарда

айрыкча дарылоонун башында уйкусууро жана баш айлануу болушу мүмкүн. Булар боло турган болсо, бейтап унаа каражаттарын башкаруудан же механизмдер менен иштөөдөн алыс болууга тийиш.

Чыгаруу формасы

Авторекс 5 мг же 10 мг:

Блистерде 10 таблеткадан.

3 блистер медицинада колдонуу боюнча нускамасы менен бирге картон таңгакта.

Сактоо шарты

Кургак, жарык тийбеген жерде, 25°C дан жогору эмес аба табында сакталат. Балдар жетпеген жерде сактоо керек.

Жарактуулук мөөнөтү

3 жыл.

Жарактуулук мөөнөтү бүткөндөн кийин колдонууга болбойт.

Берүү шарты

Дарыгердин рецепти боюнча.

Соода маркасынын жана каттоо күбөлүгүнүн ээси:
Belinda Laboratories LLP,

Astra House, Arklow Road, London,
England SE14 6EB, Улуу Британия

Өндүрүүчү

Replek Farm Ltd., Skopje

Kozle Str. 188, 1000 Skopje, Македония Республикасы

Кыргыз Республикасынын аймагында товардын сапаты боюнча керектөөчүлөрдөн арыз дооматтарды кабыл алуучу уюмдун дареги:

«Аман Фарм» ЖЧК,

Кыргыз Республикасы, Бишкек шаары, Тыныстанов көч., үй 4а, 11-батир,

E-mail: aman.pharm12@gmail.com